

CIENCIA
HUMANA
BIENESTAR



CONOCER



INTERVENIR



TRANSFORMAR



UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Decreto Ejecutivo 575 del 21 de julio de 2004

Acreditada mediante Resolución N° 15 del 31 de octubre de 2012

TRASTORNOS DE CONDUCTA

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA

COMPRENDER • INTERVENIR • TRANSFORMAR



Maestría En
Psicología Clínica



Profesora:
Dra. Cynthia González



Materia:
Trastornos de Conducta



Estudiantes:
Arelis Quintero 4-741-2000
Jessica Morales 8-758-336



Panamá, 07 de octubre de 2026.

*Formación
para un mejor
ser humano*



SALUD MENTAL
SOCIEDAD
FUTURO

*“La comprensión
de la conducta humana
es el primer paso
hacia el cambio.”*

OBJETIVO DE LA UNIDAD



Desarrollar estrategias para atender a **respuestas emocionales y conductas**, potenciando la intervención psicológica.

PROPÓSITO DE LA EXPOSICIÓN



Analizar los **trastornos de la personalidad** por grupos, identificando sus principales **respuestas emocionales y conductas**, y proponiendo **estrategias de intervención psicológica** que favorezcan el bienestar y la adaptación de la persona en sus diferentes contextos.



Comprender
las respuestas
emocionales y
conductuales.



Identificar
estrategias de
intervención
psicológica.



Promover
una mirada empática
e integral de la
persona.



Contribuir
al fortalecimiento
del quehacer
profesional.



Referencia bibliográfica:

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.



*"La intervención psicológica
transforma vidas."*

¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD?

“Más allá de los rasgos, existen patrones que impactan la vida.”



Los trastornos de la personalidad son **patrones persistentes de pensamiento, emoción y comportamiento** que se apartan significativamente de las expectativas culturales y pueden afectar las relaciones, el trabajo y otras áreas de la vida.

Estos patrones suelen ser:



Persistentes

Se mantienen en el tiempo.



Rígidos o inflexibles

Dificultad para adaptarse a diferentes situaciones.



Presentes en diferentes situaciones

Se manifiestan en varios contextos de la vida.



Asociados con dificultades

En el funcionamiento personal y social.



Referencia bibliográfica:

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.



PENSAMIENTOS
EMOCIONES
CONDUCTAS
RELACIONES
CONTEXTO

Comprender
para transformar

CLASIFICACIÓN: GRUPOS A, B Y C

Los trastornos de la personalidad se agrupan tradicionalmente en tres grupos según sus características predominantes (DSM-5-TR).

"Diferentes
patrones,
una misma
realidad humana"

GRUPO A

Extraños o excéntricos



- Trastorno paranoide de la personalidad
- Trastorno esquizoide de la personalidad
- Trastorno esquizotípico de la personalidad

Se caracterizan por patrones de desconfianza, distanciamiento social y formas peculiares de pensamiento o comportamiento.

GRUPO B

Dramáticos, emocionales o impredecibles



- Trastorno antisocial de la personalidad
- Trastorno límite de la personalidad
- Trastorno histriónico de la personalidad
- Trastorno narcisista de la personalidad

Se caracterizan por patrones de emocionalidad intensa, impulsividad y dificultades en las relaciones interpersonales.

GRUPO C

Ansiosos o temerosos



- Trastorno evitativo de la personalidad
- Trastorno dependiente de la personalidad
- Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad

Se caracterizan por patrones relacionados con la ansiedad, el temor, la necesidad de seguridad o el excesivo control.



COMPRENDER
CLASIFICAR
INTERVENIR
TRANSFORMAR

"La personalidad
también cuenta
su historia."



Referencia bibliográfica:

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.

TRASTORNO PARANOIDE DE LA PERSONALIDAD

"Se caracteriza por un patrón general de desconfianza y suspicacia hacia los demás, de tal manera que sus motivos son interpretados como malévolos, aun en ausencia de evidencia que lo justifique." (DSM-5-TR)

"Desconfiar de todo no te mantiene a salvo, solo te aleja de lo verdaderamente valioso."

CONFIANZA
REALIDAD
VÍNCULO
PERSPECTIVA
BIENESTAR



Características principales



Desconfianza generalizada hacia los demás.



Interpretación maliciosa de las intenciones ajenas.



Hipervigilancia y sensibilidad a las críticas.



Dificultad para establecer y mantener relaciones íntimas.



Rencor persistente y tendencia a la confrontación.



Percepción de amenazas incluso en situaciones neutrales.



Estrategias de intervención (enfoque en el modelo terapéutico)

Modelo aplicado: Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)

La TCC ayuda a identificar y modificar los pensamientos distorsionados de desconfianza, reducir la hipervigilancia y desarrollar formas más realistas y adaptativas de interpretar las intenciones de los demás.



Componentes de la intervención (TCC)

1

Psicoeducación

Comprender el trastorno y el papel de los pensamientos en la generación de desconfianza.

2

Identificación de pensamientos distorsionados

Detectar interpretaciones maliciosas y cuestionar su validez con evidencia.

3

Reestructuración cognitiva

Sustituir pensamientos paranoides por interpretaciones más realistas y equilibradas.

4

Entrenamiento en habilidades sociales

Favorecer la comunicación asertiva y la confianza interpersonal gradual.

5

Prevención de recaídas

Consolidar estrategias y elaborar un plan de afrontamiento ante situaciones de alta sospecha.



Resultados esperados



Disminución de la desconfianza y la hipervigilancia.



Mejora en la interpretación de las intenciones de los demás.



Relaciones interpersonales más estables y satisfactorias.



Mayor regulación emocional y menor reactividad.



Incremento de la calidad de vida y el bienestar general.



Es importante...

- Validar sus emociones sin reforzar ideas paranoides.
- Establecer una relación terapéutica basada en la transparencia y la consistencia.
- Avanzar de forma gradual, respetando su ritmo y sus límites.
- Fomentar experiencias correctivas en contextos seguros.

"La confianza también se aprende."

OBSERVAR

CUESTIONAR

COMPRENDER

AVANZAR

PERSPECTIVA
DIÁLOGO
CONEXIÓN
BIENESTAR

"A veces, lo que parece una amenaza, es solo una diferente perspectiva."



Referencias bibliográficas:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.
- Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización*. Editorial Descleé de Brouwer.
- Turner, H., Kingdon, D., & Turkington, D. (2016). *Cognitive-behavioral therapy for paranoid personality disorder: A clinical review*. *Journal of Personality Disorders*, 30(1), 78-93.
- Westen, D. (1998). *The clinical status of schizotypal personality disorder*. *Schizophrenia Bulletin*, 24(1), 1-16.

TRASTORNO ESQUIZOIDE DE LA PERSONALIDAD

"Se caracteriza por un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y una gama restringida de expresión emocional, mostrando poco interés en establecer vínculos con los demás." (DSM-5-TR)

"La soledad no siempre es ausencia de otros, a veces es una forma de existir en el mundo."

AUTONOMÍA
CALMA
RESPECTO
RITMO PROPIO
BIENESTAR

Comprender también es una forma de acompañar.

"Pequeños vínculos también pueden generar grandes cambios."



Características principales



Marcado distanciamiento de las relaciones sociales.



Expresión emocional limitada.



Poco interés en actividades sociales o en establecer vínculos.



Preferencia por la soledad.



Intereses restringidos, generalmente de carácter intelectual o abstracto.



Modelo terapéutico aplicado: Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)

La TCC se adapta al estilo del paciente esquizoide, respetando su necesidad de autonomía y su ritmo, y se centra en desarrollar habilidades sociales, aumentar la flexibilidad cognitiva y favorecer una mayor conexión con el entorno de manera gradual.



Componentes de la intervención (TCC)



Psicoeducación

Comprender el trastorno y sus efectos en la vida diaria.



Identificación de pensamientos y creencias

Explorar ideas de autosuficiencia extrema y desinterés social.



Entrenamiento en habilidades sociales

Practicar la interacción en contextos seguros y significativos.



Reestructuración cognitiva

Cuestionar interpretaciones rígidas y fomentar perspectivas más flexibles.



Exposición gradual

Incrementar la participación en actividades sociales de forma progresiva y planificada.



Resultados esperados



Mayor apertura a experiencias sociales significativas.



Incremento en la expresión emocional.



Mejora en la calidad de las relaciones interpersonales.



Mayor flexibilidad cognitiva.



Aumento del bienestar general y la satisfacción vital.



Es importante...



Respetar su necesidad de espacio.



Avanzar a su propio ritmo.



Evitar presionar la socialización.



Validar sus intereses y formas de vida.



Fomentar un ambiente terapéutico seguro y no invasivo.



Referencias bibliográficas:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.
- Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Young, J. E. (2017). *Terapia de esquemas: Guía práctica*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Millon, T., & Davis, R. D. (2015). *Trastornos de la personalidad en la vida moderna (2.ª ed.)*. Elsevier.



CONOCER



ACEPTAR



AVANZAR

DIFERENTES
FORMAS
DE ESTAR
TAMBIÉN
SON VÁLIDAS

TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO DE LA PERSONALIDAD

“Se caracteriza por un patrón general de malestar en las relaciones interpersonales, distorsiones cognitivas o perceptuales y un comportamiento excéntrico.” (DSM-5-TR)

“Lo diferente también es parte del ser humano.”

ACEPTACIÓN
EMPATÍA
REALIDAD
CONEXIÓN
POSIBILIDADES



Características principales



Ideas de referencia (creencias inusuales).



Experiencias perceptuales inusuales (ilusiones, despersonalización).



Pensamiento y lenguaje excéntricos.



Afecto inapropiado o restringido.



Ansiedad social intensa.



Conducta y apariencia excéntrica.



“Comprender también es incluir.”



Modelo terapéutico aplicado: Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)

La TCC se adapta a las características del trastorno esquizotípico, permitiendo trabajar las creencias inusuales, la ansiedad social y las dificultades en la interpretación de la realidad, desde un enfoque colaborativo, gradual y respetuoso del estilo del paciente.



Componentes de la intervención (TCC)

1

Psicoeducación

Información sobre el trastorno y normalización de experiencias inusuales.

2

Identificación de pensamientos disfuncionales

Cuestionar creencias de referencia y pensamientos mágicos.

3

Reestructuración cognitiva

Generar interpretaciones más realistas y flexibles.

4

Entrenamiento en habilidades sociales

Práctica gradual en contextos seguros.

5

Manejo de la ansiedad

Uso de técnicas de relajación, mindfulness y exposición gradual.

6

Prevención de recaídas

Consolidar aprendizajes y plan de afrontamiento a largo plazo.



Resultados esperados



Reducción de la ansiedad social.



Mayor capacidad para cuestionar creencias inusuales.



Mejora en la interpretación de la realidad.



Incremento en la interacción social y funcionalidad.



Fortalecimiento de la autoestima y la calidad de vida.



Estrategias complementarias

- Técnicas de mindfulness.
- Entrenamiento en habilidades sociales.
- Apoyo familiar.
- Intervenciones grupales.
- Coordinación con tratamiento farmacológico (si es necesario).



Referencias bibliográficas:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.
- Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización*. Editorial Desclée de Brouwer.
- Turner, H., Kingdon, D., & Turkington, D. (2016). *Cognitive-behavioral therapy for schizotypal personality disorder: A clinical review*. *Journal of Personality Disorders*, 30(1), 78–93.
- Morrison, A. P. (2014). *CBT for psychosis and related problems: A practical guide*. Guilford Press.

“La empatía abre puentes donde otros solo ven distancia.”

ESCUCHAR
ACOMPañAR
VALIDAR
CONSTRUIR
INTEGRAR

TRASTORNO ANTISOCIAL DE LA PERSONALIDAD

Patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que se manifiesta desde la adolescencia y continúa en la vida adulta." (DSM-5-TR)

"La ausencia de empatía no es fortaleza, es una herida que nunca aprendió a mirar al otro."

LÍMITES
RESPONSABILIDAD
CONSECUENCIAS
CAMBIO
CONVIVENCIA



Respuestas emocionales



Baja empatía y escasa conexión emocional con los demás.



Irritabilidad y baja tolerancia a la frustración.



Búsqueda constante de excitación y sensaciones.



Dificultad para experimentar culpa o remordimiento.



Emociones superficiales y utilitarias.



Conductas frecuentes



Engaño y manipulación.



Incumplimiento de normas y leyes.



Impulsividad y conductas de riesgo.



Agresividad física o verbal.



Irresponsabilidad laboral, académica y familiar.



Uso instrumental de las relaciones interpersonales.



Modelo terapéutico aplicado

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)

La TCC se centra en modificar patrones de pensamiento, creencias y conductas disfuncionales, favoreciendo el desarrollo de habilidades de autocontrol, toma de decisiones y consideración de las consecuencias de sus actos.

"No se trata solo de cambiar la conducta, sino de construir responsabilidad y una vida con sentido."



Estrategias de intervención (TCC)

1

Reestructuración cognitiva: identificar y cuestionar creencias que justifican conductas antisociales.

2

Entrenamiento en resolución de problemas: analizar alternativas y consecuencias.

3

Manejo de la impulsividad: técnicas de autocontrol y regulación emocional.

4

Entrenamiento en habilidades sociales: fomentar conductas prosociales y respeto por los demás.



Objetivo terapéutico



Disminuir conductas antisociales y de riesgo.



Aumentar la responsabilidad y el cumplimiento de normas.



Desarrollar habilidades de autocontrol y empatía.



Favorecer la integración social, laboral y familiar.



Construir un proyecto de vida más estable y adaptativo.



Referencias bibliográficas:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing.
- Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Glick, I. D., & Giblin, M. J. (2015). *Cognitive-behavioral therapy for antisocial personality disorder*. *Journal of Personality Disorders*, 29(1), 95-108.
- Millon, T., & Davis, R. D. (2015). *Trastornos de la personalidad en la vida moderna* (2.ª ed.). Elsevier.

"Toda conducta tiene una consecuencia."

MANIPULA
DESAFÍA
MIENTE
TRANSGREDE
¿CAMBIA?

CONSECUENCIAS

OPORTUNIDADES
de CAMBIO

REFLEXIONAR
RESPETAR
ELEGIR
CONSTRUIR
AVANZAR

TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

"Se caracteriza por un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen, las emociones y la conducta, con una notable impulsividad." (DSM-5-TR)

"Siento todo demasiado... intensamente."

Miedo al abandono

EMOCIÓN
IDENTIDAD
RELACIONES
EQUILIBRIO
POSIBILIDADES

Vacío

Mis emociones también son válidas, aunque sean intensas.

REGULAR

ACEPTAR

CONSTRUIR

AVANZAR

Sanar también es una forma de avanzar.

ESPERANZA
AUTOCONTROL
RELACIONES SANAS
BIENESTAR
NUEVOS COMIENZOS



Respuestas emocionales



Intensidad emocional y cambios de humor rápidos.



Miedo intenso al abandono.



Sentimientos de vacío.



Ira intensa y dificultad para regular la frustración.



Ansiedad y tristeza frecuentes.



Inestabilidad en la autoimagen y baja autoestima.



Conductas frecuentes



Relaciones interpersonales intensas e inestables (idealización y devaluación).



Impulsividad (gastos, sexualidad, consumo de sustancias, conductas de riesgo).



Conductas autolesivas.



Amenazas o intentos de suicidio.



Dificultad para mantener límites en las relaciones.



Cambios frecuentes de metas, valores y planes de vida.



Modelo terapéutico aplicado

Terapia Dialéctica Conductual (DBT)

La DBT, desarrollada por Marsha Linehan, combina estrategias de cambio y aceptación, y ha demostrado ser eficaz para la regulación emocional, la disminución de conductas autolesivas y la mejora en las relaciones interpersonales.



"No se trata de dejar de sentir, sino de aprender a gestionar lo que siento."



Estrategias de intervención (DBT)

1

Entrenamiento en habilidades de regulación emocional (identificar, comprender y modular emociones).

2

Tolerancia al malestar (estrategias para afrontar crisis sin conductas autolesivas).

3

Habilidades de eficacia interpersonal (comunicación asertiva y establecimiento de límites).

4

Mindfulness (atención plena para vivir el momento presente).



Objetivos terapéuticos



Disminuir conductas autolesivas y de riesgo.



Mejorar la regulación emocional.



Establecer relaciones interpersonales más estables.



Fortalecer la autoimagen y la autoestima.



Favorecer un proyecto de vida más estable y significativo.



Referencias bibliográficas:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.
- Linehan, M. M. (2015). *DBT® Skills Training Manual (2.ª ed.)*. Guilford Press.
- Kernberg, O. F. (2016). *Trastornos graves de la personalidad. Manual moderno*.
- Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización*. Editorial Desclée de Brouwer.

TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD

"No es solo llamar la atención, es sentir que sin ella no existo."

"Se caracteriza por un patrón general de búsqueda excesiva de atención, expresión emocional exagerada y necesidad de ser el centro de las interacciones sociales." (DSM-5-TR)

EXPRESIÓN
ATENCIÓN
EMOCIÓN
VÍNCULO
AUTENTICIDAD
EQUILIBRIO



Respuestas emocionales



Necesidad intensa de aprobación y reconocimiento.



Ansiedad cuando no recibe atención.



Emociones superficiales y cambiantes.



Baja tolerancia a la frustración.



Miedo al rechazo o a pasar desapercibido.



Tendencia a idealizar las relaciones y vivirlas de forma intensa.



Conductas frecuentes



Búsqueda constante de atención.



Conducta seductora o coqueta inapropiada.



Expresión emocional exagerada y teatral.



Preocupación excesiva por la apariencia física.



Habla llamativa, pero con poco contenido.



Relaciones interpersonales superficiales y cambiantes.



Modelo terapéutico aplicado

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)

La TCC ayuda a identificar y modificar pensamientos disfuncionales sobre la autoimagen, la necesidad de aprobación y los patrones de conducta centrados en la atención, favoreciendo una autoevaluación más realista y relaciones interpersonales más auténticas.

"La verdadera seguridad no está en la mirada de otros, sino en el valor que te das a ti mismo."



Estrategias de intervención (TCC)

1

Reestructuración cognitiva: cuestionar creencias disfuncionales sobre el valor personal y la atención.

2

Entrenamiento en habilidades sociales: fomentar formas de interacción más auténticas.

3

Regulación emocional: identificar y manejar emociones intensas y cambiantes.

4

Trabajo en la autoestima: fortalecer el autoconcepto independiente de la validación externa.



Objetivos terapéuticos



Disminuir la necesidad excesiva de atención.



Lograr una expresión emocional más auténtica y estable.



Mejorar la calidad de las relaciones interpersonales.



Desarrollar una autoimagen más realista y positiva.



Aumentar la tolerancia a la frustración y al rechazo.



Referencias bibliográficas:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.
- Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Terapia de esquemas: Guía práctica*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Millon, T., & Davis, R. D. (2015). *Trastornos de la personalidad en la vida moderna* (2.ª ed.). Elsevier.

CONOCER
ACEPTAR
REGULAR
CONECTAR
AVANZAR

SER VISTO

SER VALORADO

SER AUTÉNTICO

"Detrás del personaje también hay una historia que merece ser escuchada."

Más que apariencia, también hay emociones reales. ❤️

TRASTORNO NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD

"Se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía, que se inicia en la adultez temprana y se presenta en diversos contextos." (DSM-5-TR)

"Detrás de la aparente confianza, puede haber una profunda inseguridad."

APARIENCIA
RECONOCIMIENTO
CONTROL
VALIDACIÓN
AUTOIMPORTANCIA



Respuestas emocionales



Sensación de grandiosidad y superioridad.



Alta sensibilidad a la crítica y al rechazo (vergüenza, humillación).



Necesidad constante de admiración y validación.



Dificultad para reconocer y regular emociones propias.



Sentimientos de vacío y enojo cuando no recibe reconocimiento.



Conductas frecuentes



Búsqueda constante de admiración y elogios.



Exageración de logros y talentos.



Desvalorización o menosprecio de los demás.



Uso instrumental de las relaciones interpersonales.



Dificultad para aceptar críticas.



Envidia de los demás o creencia de que otros le envidian.



Modelo terapéutico aplicado

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) y Terapia de Esquemas

La TCC y la Terapia de Esquemas ayudan a identificar y modificar creencias disfuncionales (grandiosidad, derecho, desvalorización de otros), trabajando esquemas tempranos de defectuosidad y búsqueda de aprobación, favoreciendo una autoimagen más realista y relaciones más saludables.

"El verdadero valor no se mide en la admiración de los demás, sino en la capacidad de ser auténtico."



Estrategias de intervención (TCC y Terapia de Esquemas)

1

Reestructuración cognitiva: cuestionar pensamientos de grandiosidad y derecho.

2

Trabajo con esquemas: identificar y modificar esquemas de grandiosidad, defectuosidad y búsqueda de aprobación.

3

Entrenamiento en empatía: ejercicios de toma de perspectiva y reconocimiento emocional en otros.

4

Regulación emocional: manejo de la frustración y tolerancia a la crítica.



Objetivos terapéuticos



Desarrollar una autoimagen más realista y estable.



Disminuir la necesidad excesiva de admiración.



Mejorar la empatía y la calidad de las relaciones interpersonales.



Incrementar la tolerancia a la crítica.



Favorecer un sentido de identidad más auténtico y coherente.



Referencias bibliográficas:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.
- Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Terapia de esquemas: Guía práctica*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Millon, T., & Davis, R. D. (2015). *Trastornos de la personalidad en la vida moderna (2.ª ed.)*. Elsevier.

Gran imagen por fuera... mucha fragilidad por dentro.

ADMIRACIÓN
SIN EMPATÍA

RELACIONES FRÁGILES

"No todo lo que brilla es autenticidad."

AUTENTICIDAD
EMPATÍA
HUMILDAD
CONEXIÓN
BIENESTAR

TRASTORNO EVITATIVO DE LA PERSONALIDAD

"Se caracteriza por un patrón general de inhibición social, sentimientos de inadecuación y una hipersensibilidad a la evaluación negativa." (DSM-5-TR)

"Quiero conectar, pero el miedo al rechazo me detiene."

DETRÁS DEL AISLAMIENTO TAMBIÉN HAY EL DESEO DE PERTENECER.



Respuestas emocionales



Ansiedad intensa en situaciones sociales.



Miedo al rechazo o a la crítica.



Sentimientos de inadecuación e inferioridad.



Vergüenza y autocrítica constante.



Deseo de cercanía, pero con temor a ser juzgado.



Tristeza y sensación de soledad.



Conductas frecuentes



Evita actividades sociales y nuevas experiencias.



Se muestra tímido, reservado y distante.



Dificultad para iniciar o mantener relaciones interpersonales.



Busca seguridad en la rutina y en entornos conocidos.



Puede rechazar oportunidades por miedo al fracaso o la crítica.



Tendencia al aislamiento social.



Modelo terapéutico aplicado

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)

La TCC ayuda a identificar y modificar los pensamientos negativos y las creencias disfuncionales sobre uno mismo y los demás, favoreciendo la exposición gradual a situaciones sociales y el desarrollo de habilidades sociales.

"No se trata de vencer el miedo de inmediato, sino de darle espacio al valor para que crezca poco a poco."



Estrategias de intervención (TCC)

1

Reestructuración cognitiva: identificar y cuestionar creencias de inadecuación y rechazo.

2

Exposición gradual: enfrentar de manera progresiva situaciones sociales temidas.

3

Entrenamiento en habilidades sociales: mejorar la comunicación y la asertividad.

4

Autocompasión: fomentar una actitud más amable y realista hacia uno mismo.



Objetivos terapéuticos



Disminuir la ansiedad social.



Incrementar la autoestima y la autoeficacia.



Desarrollar y mantener relaciones interpersonales más satisfactorias.



Ampliar la participación en actividades sociales.



Favorecer un proyecto de vida más pleno y significativo.



Referencias bibliográficas:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing.
- Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Terapia de esquemas: Guía práctica*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Clark, D. M., & Wells, A. (1995). *A cognitive model of social phobia*. En R. G. Heimberg, M. R. Liebowitz, D. A. Hope & F. R. Schneier (Eds.), *Social Phobia: Diagnosis, Assessment, and Treatment* (pp. 69-93). Guilford Press.

Miedo
Inseguridad
Autocrítica
Distancia
Soledad

Eres más
que tus miedos.
También
mereces estar
aquí

PEQUEÑOS PASOS

TAMBIÉN SON AVANCES

"Con acompañamiento y estrategias adecuadas, es posible construir conexiones significativas."

VALIDAR
COMPRENDER
ACOMPañAR
FORTALECER
INCLUIR

ES SEGURO
SER YO

TRASTORNO DEPENDIENTE DE LA PERSONALIDAD

“Se caracteriza por una necesidad generalizada y excesiva de ser cuidado, que conduce a un comportamiento sumiso y de apego, y a un intenso miedo a la separación.” (DSM-5-TR)

DEPENDENCIA
MIEDO AL ABANDONO
BAJA AUTONOMÍA
SUMISIÓN
BÚSQUEDA DE APOYO
INSEGURIDAD

“Me siento seguro cuando alguien está conmigo.” ♥

¿Y si me deja? ♥

También puedo sola ♥

CONFIANZA

AUTONOMÍA

DECISIONES

IDENTIDAD

LIBERTAD

“No necesito que alguien me complete, yo también soy suficiente.” ♥

APRENDER
SOLTAR
CONFIAR
CRECER
SER TÚ



Respuestas emocionales



Ansiedad ante la posibilidad de quedar solo.



Miedo intenso al abandono.



Baja autoestima y sensación de incapacidad.



Necesidad constante de aprobación.



Inseguridad y duda en la toma de decisiones.



Tristeza o desesperanza cuando se percibe rechazo o distancia.



Conductas frecuentes



Busca constantemente consejo y guía de los demás.



Dificultad para tomar decisiones sin apoyo.



Delegación excesiva de responsabilidades.



Sumisión en las relaciones por miedo a perder el apoyo.



Incomodidad o malestar al estar solo.



Inicia rápidamente nuevas relaciones para evitar la soledad.



Modelo terapéutico aplicado

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) y Terapia de Esquemas

La TCC ayuda a identificar y modificar creencias irracionales sobre la incapacidad personal y la necesidad excesiva de apoyo. La Terapia de Esquemas trabaja en patrones tempranos de dependencia, fortaleciendo la autonomía, la autoestima y la construcción de un sentido de identidad propio.

“La verdadera seguridad no está en depender de otros, sino en confiar en tus propias capacidades.”



Estrategias de intervención

1

Reestructuración cognitiva: cuestionar creencias de incapacidad y dependencia.

2

Entrenamiento en habilidades de autonomía: toma de decisiones y resolución de problemas.

3

Exposición gradual a la independencia: realizar actividades sin apoyo de otros.

4

Trabajo en esquemas: identificar y modificar esquemas de abandono, vulnerabilidad y dependencia.



Objetivos terapéuticos



Fortalecer la autoestima y la autoconfianza.



Disminuir la necesidad excesiva de apoyo.



Desarrollar habilidades de toma de decisiones.



Manejar el miedo al abandono.



Favorecer la construcción de una identidad propia más sólida.



Lograr relaciones más equilibradas y saludables.



Referencias bibliográficas:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.
- Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Young, J. E., Klosko, J. S. & Weishaar, M. E. (2003). *Terapia de esquemas: Guía práctica*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Millon, T., & Davis, R. D. (2015). *Trastornos de la personalidad en la vida moderna (2.ª ed.)*. Elsevier.

TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO DE LA PERSONALIDAD

"Se caracteriza por un patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionismo, el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la apertura y la eficiencia." (DSM-5-TR)

"Si no está perfecto, siento que algo malo puede pasar."

- ☒ PLANIFICAR
- ☒ ORGANIZAR
- ☒ REVISAR
- ☒ CONTROLAR
- ☐ HACER BIEN
- ☐ EVITAR ERRORES

EL CONTROL TAMBIÉN PUEDE SER UNA PRISIÓN

La vida también sucede cuando sueltas el control.



Respuestas emocionales



Ansiedad ante la incertidumbre y el desorden.



Tensión constante.



Miedo a cometer errores.



Sentimientos de culpa.



Dificultad para experimentar placer o relajación.



Irritabilidad cuando las cosas no se hacen "como deben ser".



Conductas frecuentes



Preocupación excesiva por reglas, detalles, orden y listas.



Perfeccionismo que interfiere con la finalización de tareas.



Necesidad de control en sí mismos y en los demás.



Rigidez y resistencia al cambio.



Dificultad para delegar.



Exceso de dedicación al trabajo, en detrimento del ocio y las relaciones.



Modelo terapéutico aplicado

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) y Terapia de Esquemas

La TCC ayuda a identificar y modificar creencias disfuncionales sobre el control, el perfeccionismo y la necesidad de orden. La Terapia de Esquemas trabaja esquemas tempranos de estándares inflexibles y autocrítica, favoreciendo una mayor flexibilidad, autocompasión y equilibrio en la vida personal, laboral y en las relaciones.

"La perfección no es un destino, sino un estándar que te aleja de lo que realmente importa."



Estrategias de intervención

1

Reestructuración cognitiva: cuestionar creencias perfeccionistas e intolerancia al error.

2

Exposición y prevención de respuesta (EPR): tolerar la incertidumbre y la imperfección.

3

Entrenamiento en flexibilidad cognitiva: practicar la adaptación al cambio.

4

Técnicas de mindfulness: reducir la rumiación y aumentar la aceptación del presente.



Objetivos terapéuticos



Disminuir la necesidad excesiva de control.



Reducir la ansiedad asociada al perfeccionismo.



Incrementar la tolerancia a la incertidumbre y al error.



Favorecer un equilibrio entre trabajo, ocio y relaciones.



Desarrollar una autoevaluación más compasiva y realista.



Mejorar la calidad de vida y la flexibilidad interpersonal.



Referencias bibliográficas:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Terapia de esquemas: Guía práctica*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). *Terapia de aceptación y compromiso (ACT)*. Desclee de Brouwer.

PLANES
METAS
RESPONSABILIDADES
PROYECTOS
CONTROL
RESULTADOS

- ☒ Hacer bien
- ☒ Ser eficiente
- ☒ No fallar
- ☒ Mantener el control
- ☒ Todo en orden

ESTÁ BIEN SOLTAR TAMBIÉN

EQUILIBRIO
Flexibilizada
TAMBIÉN

"Hacer lo suficientemente bien también es avanzar."

EQUILIBRIO
FLEXIBILIDAD
BIENESTAR

Comparación de modelos terapéuticos: Grupos A, B y C

"Distintos caminos, un mismo objetivo: una vida más funcional y significativa."

*"Comprender
para intervenir,
comparar para
integrar."* ♥



**OBJETIVO
COMÚN**

Reducir el malestar,
mejorar el funcionamiento
personal, social y emocional,
y favorecer una mejor
calidad de vida.



A
PENSAMIENTO



B
EMOCIÓN



C
RELACIÓN

Grupo	Modelo(s) terapéutico(s) más utilizado(s)	Enfoque principal	Técnicas representativas	Fortalezas	Desafíos
 Grupo A (Paranoide, Esquizoide, Esquizotípico)	Terapia Cognitivo- Conductual (TCC) Terapia de Esquemas	Modificación de pensamientos disfuncionales y mejora de habilidades sociales.	• Reestructuración cognitiva • Entrenamiento en habilidades sociales • Terapia de esquemas	Favorece el análisis racional y la adaptación social progresiva.	Resistencia inicial al tratamiento, desconfianza y dificultad para el vínculo terapéutico.
 Grupo B (Antisocial, Límite, Histriónico, Narcisista)	TCC, Terapia Dialéctica Conductual (DBT), Terapia de Esquemas	Regulación emocional, control de impulsos y modificación de patrones relacionales disfuncionales.	• DBT (mindfulness, regulación emocional) • Reestructuración cognitiva • Entrenamiento en habilidades interpersonales • Trabajo con esquemas	Evidencia sólida en la regulación emocional y la mejora de relaciones interpersonales.	Inestabilidad emocional, impulsividad y mayor riesgo de abandono terapéutico.
 Grupo C (Evitativo, Dependiente, Obsesivo-Compulsivo)	TCC, Terapia de Esquemas	Fortalecimiento de la autoestima, autonomía y flexibilidad cognitiva.	• Exposición gradual • Reestructuración cognitiva • Entrenamiento en autoafirmación • Trabajo con esquemas	Alta efectividad en la reducción de la ansiedad y el perfeccionismo, y en el desarrollo de mayor autonomía.	Dependencia del terapeuta, miedo al rechazo y dificultad para tolerar la incertidumbre.

*"Diferentes
desafíos,
mismas
posibilidades
de cambio."* ♥



*Cada persona es única.
El modelo terapéutico se adapta
a sus necesidades, contexto
y fortalezas."* ♥



*"La terapia
no cambia quién eres,
sino lo que puedes hacer
con lo que eres."* ♥

CIENCIA
EMPATÍA
ESTRATEGIA
CAMBIO REAL

Referencias bibliográficas:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.
- Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Terapia de esquemas: Guía práctica*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Linehan, M. M. (2015). *DBT® Skills Training Manual (2.ª ed.)*. Guilford Press.



Respuestas emocionales y conductuales: ¿CÓMO INTERVENIR?

Del entendimiento a la acción: intervenir es acompañar, no solo cambiar conductas.

"Cada emoción nos comunica algo y cada conducta tiene un sentido."

OBSERVAR
COMPRENDER
VALIDAR
ORIENTAR
ACOMPañAR
TRANSFORMAR

1 Evaluación integral



- Analizar la historia clínica y el contexto.
- Identificar patrones emocionales y conductuales.
- Considerar la personalidad, comorbilidades y factores ambientales.

*Comprender antes de intervenir.**

2 Validación emocional



- Reconocer y aceptar las emociones del paciente.
- Favorecer un espacio seguro y sin juicio.
- La validación reduce la resistencia y mejora la alianza terapéutica.

Toda emoción es válida, aunque la conducta no siempre lo sea.

3 Psicoeducación



- Explicar el trastorno, sus características y posibles causas.
- Normalizar la experiencia del paciente.
- Promover la responsabilidad personal y la motivación al cambio.

Conocer también empodera.

4 Intervención terapéutica



- Aplicar el modelo terapéutico más adecuado (TCC, DBT, Terapia de Esquemas, entre otros).
- Trabajar la regulación emocional, la modificación de conductas y el desarrollo de habilidades.
- Adaptar las estrategias al grupo de personalidad (A, B o C).

Estrategias basadas en la evidencia, para cambios reales.

5 Seguimiento y ajuste



- Monitorear el progreso de manera continua.
- Ajustar técnicas según la respuesta del paciente.
- Prevenir recaídas y reforzar los logros.

El cambio es un proceso, no un evento.

6 Enfoque integral del bienestar



- Fomentar redes de apoyo.
- Promover hábitos de vida saludable (sueño, actividad física, alimentación).
- Trabajar en la autoestima, el sentido de vida y la funcionalidad social.

Más que reducir síntomas, se trata de construir una vida significativa.

Aquí también se construyen nuevos comienzos

ESCUCHA
ACOMPaña
GUÍA
CREE
INCLUYE

UN PASO
A LA VEZ
ES AVANZAR

AUTOCONOCIMIENTO
REGULACIÓN EMOCIONAL
HABILIDADES
RELACIONES SANAS
BIENESTAR

*Personas reales
Historias únicas
Cambios posibles*

"Intervenir no es cambiar quién eres, sino ayudarte a ser la mejor versión de ti."

PERSONAS
PROCESOS
PROPÓSITOS
POSIBILIDADES

Referencias bibliográficas:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.
- Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Linehan, M.M. (2015). *DBT® Skills Training Manual (2.ª ed.)*. Guilford Press.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Terapia de esquemas: Guía práctica*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Hayes, S.C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). *Terapia de aceptación y compromiso (ACT)*. Desclee de Brouwer.

CASO PRÁCTICO

De la teoría a la intervención: integrar, comprender y actuar.

ANALIZAR
INTEGRAR
PROPONER
REFLEXIONAR
APRENDER

1 Presentación del caso



Sofía, 23 años, estudiante universitaria.

Consulta por ansiedad intensa, problemas en sus relaciones interpersonales y sensación constante de vacío. Refiere cambios bruscos de humor, miedo al abandono y conductas impulsivas. Ha tenido relaciones de pareja inestables y refiere autolesiones en momentos de angustia.

2 Información relevante



Historia de relaciones intensas e inestables.



Respuestas emocionales muy intensas (ira, miedo, tristeza).



Conductas impulsivas (autolesiones, gastos excesivos).



Autoimagen inestable y sentimientos crónicos de vacío.



Sin antecedentes psiquiátricos previos. Red de apoyo limitada.

3 Análisis del caso



- ¿A qué grupo de trastornos de la personalidad podría corresponder?
- ¿Qué respuestas emocionales y conductuales predominan?
- ¿Qué factores de mantenimiento pueden identificarse?
- ¿Qué otros diagnósticos diferenciales considerarías?

4 Propuesta de intervención



Modelo terapéutico sugerido: Terapia Dialéctica Conductual (DBT).



Objetivos: regulación emocional, tolerancia al malestar, habilidades interpersonales y construcción de una identidad más estable.



Estrategias iniciales: psicoeducación, validación emocional, entrenamiento en habilidades y plan de seguridad.



Trabajo multidisciplinario: psicoterapia individual, posible apoyo psiquiátrico y fortalecimiento de la red de apoyo.

5 Preguntas para la reflexión



- ¿Cómo influye el contexto en la presentación del caso?
- ¿Qué riesgos deben considerarse?
- ¿Cómo adaptarías la intervención a sus necesidades y recursos?
- ¿Qué papel juega la alianza terapéutica en este caso?

6 Conclusión



- ✓ El caso muestra la importancia de una evaluación integral.
- ✓ La intervención debe ser individualizada y basada en la evidencia.
- ✓ Comprender las respuestas emocionales y conductuales permite diseñar estrategias más efectivas.
- ✓ El cambio es posible con un abordaje terapéutico consistente, empático y colaborativo.

"Detrás de cada conducta hay una historia que merece ser escuchada, no solo etiquetada."

LA EMPATÍA TAMBIÉN ES UNA HERRAMIENTA CLÍNICA

Escuchar también es intervenir.

Cada caso es único. La teoría guía, pero la persona da sentido.

EVALUAR
COMPRENDER
PLANIFICAR
ACOMPañAR
TRANSFORMAR

PEQUEÑOS PASOS
GRANDES CAMBIOS

"Comprender un caso es el primer paso para transformar una vida."

✓ Paciente
✓ Contexto
✓ Emociones
✓ Conductas
✓ Intervención
✓ Seguimiento

MÁS
HUMANIDAD
MEJORES
PROCESOS
MAYORES
OPORTUNIDADES

Referencias bibliográficas:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.
- Linehan, M. M. (2015). *DBT® Skills Training Manual (2.ª ed.)*. Guilford Press.
- Beck, J. S. (2020). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y aplicación*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Terapia de esquemas: Guía práctica*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Caballo, V. E. (2019). *Manual de trastornos de la personalidad*. Pirámide.

CASO PRÁCTICO 2

Cuando el miedo al rechazo limita mis oportunidades

TRASTORNO EVITATIVO DE LA PERSONALIDAD

— El deseo de conectar existe, — pero el miedo lo detiene.

"No es que no quiera estar con otros... es que tengo miedo de no ser suficiente."



Las personas con evitación no son distantes por elección, sino por miedo.

COMPRENDER
ACOMPañAR
VALIDAR
INTERVENIR
INCLUIR
TRANSFORMAR

1 Presentación del caso

¿Y si se burlan?
Mejor no...

María, 24 años, estudiante universitaria, consulta porque tiene dificultades para relacionarse con otras personas. Aunque le gustaría tener amigos y participar más en actividades académicas, evita hacerlo por temor a ser criticada o rechazada. Siente que los demás podrían considerarla poco inteligente o incompetente. Prefiere pasar desapercibida, evita las exposiciones en clase y le cuesta iniciar conversaciones.

2 Información relevante



Emociones predominantes

- Ansiedad en situaciones sociales.
- Miedo al rechazo y a la crítica.
- Vergüenza.
- Inseguridad.
- Sentimientos de inferioridad.



Conductas observadas

- Evita participar en clase.
- Dificultad para iniciar o mantener relaciones.
- Aislamiento social.
- Evita actividades grupales.
- Busca pasar desapercibida.



Pensamientos frecuentes

- "Van a pensar que no soy suficiente."
- "Si me equivoco, me van a juzgar."
- "Es mejor no participar."
- "No tengo nada interesante que decir."

3 Análisis del caso



¿A qué grupo corresponde?

Grupo C — Trastorno de la Personalidad Evitativo.



¿Qué características predominan?

- Miedo al rechazo y a la crítica.
- Sentimientos de inferioridad.
- Ansiedad interpersonal.
- Evitación de situaciones sociales.
- Deseo de relacionarse, pero con miedo a hacerlo.
- Interpretación negativa de las situaciones.



¿Qué factores de mantenimiento pueden identificarse?

- Evitación (alivio temporal de la ansiedad).
- Pensamientos negativos y autocrítica.
- Baja autoestima.
- Pocas experiencias sociales correctivas.
- Aumento del miedo y aislamiento.

4 Propuesta de intervención



Modelo terapéutico sugerido
Terapia Cognitivo-Conductual (TCC).



Objetivo general

Reducir la ansiedad interpersonal, modificar pensamientos disfuncionales y favorecer la participación social progresiva.



Estrategias y técnicas

- Reestructuración cognitiva.
- Exposición gradual a situaciones sociales.
- Entrenamiento en habilidades sociales.
- Autocompasión y trabajo en autoestima.
- Prevención de recaídas.

5 Preguntas para la reflexión



- 1 ¿Qué características del caso son compatibles con el Trastorno Evitativo?
- 2 ¿Qué conducta está manteniendo principalmente el problema?
- 3 ¿Qué otros diagnósticos diferenciales considerarías?
- 4 ¿Qué técnica aplicarías inicialmente y por qué?
- 5 ¿Cómo puede el terapeuta fomentar experiencias sociales correctivas?

6 Conclusión



- El caso muestra cómo el miedo al rechazo puede limitar significativamente la vida personal, académica y social.
- La intervención psicológica permite desarrollar mayor seguridad, modificar pensamientos negativos y construir relaciones más saludables.
- Con apoyo adecuado, es posible superar la evitación y avanzar hacia una vida más plena y significativa.

"Pequeños pasos también son grandes avances."

La evitación no define quién eres, es solo una parte de tu historia. Y tu historia todavía puede cambiar.

MÁS
CONEXIÓN
MÁS OPORTUNIDADES
MÁS BIENESTAR

Personas reales,
Cambios posibles

Referencias bibliográficas:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.
- Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Terapia de esquemas: Guía práctica*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Linehan, M. M. (2015). *DBT® Skills Training Manual (2.ª ed.)*. Guilford Press.

CONCLUSIONES

"Conocer para comprender, comprender para transformar."

"Cada persona es más que un diagnóstico, es una historia, una posibilidad de cambio." ♥

CONOCIMIENTO
EMPATÍA
REFLEXIÓN
ACCIÓN
BIENESTAR

1

Los trastornos de la personalidad son complejos y multidimensionales.



Involucran factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en las respuestas emocionales y conductuales.

2

Cada grupo (A, B y C) presenta características distintivas.



Aunque tienen diferencias en su manifestación, todos comparten patrones de pensamiento, emoción y conducta que pueden generar malestar significativo.

3

La intervención terapéutica debe ser individualizada.



No existe un único enfoque eficaz para todos los trastornos. La elección del modelo terapéutico depende de las necesidades, características y contexto de cada persona.

4

La comprensión de las respuestas emocionales y conductuales es clave.



Permite diseñar estrategias de intervención más efectivas, que favorezcan la regulación emocional, la adaptación y la mejora en la calidad de vida.

5

El trabajo terapéutico genera cambios significativos.



A través de la psicoterapia, la psicoeducación y el apoyo continuo, es posible desarrollar mayor autoconocimiento, flexibilidad cognitiva y relaciones más saludables.

6

Una mirada humana y libre de estigma es esencial.



Detrás de cada diagnóstico hay una persona con una historia única. El respeto, la empatía y la inclusión favorecen el proceso terapéutico y la construcción de una vida más plena.

Salud mental
hoy,
mejores
mañanas ♥

ACEPTAR

COMPRENDER

ACOMPañAR

INCLUIR

TRANSFORMAR

MÁS
CONCIENCIA

MÁS
EMPATÍA

MÁS
INCLUSIÓN

MÁS
BIENESTAR

PEQUEÑOS
CAMBIOS
GRANDES
HISTORIAS ♥

DIVERSIDAD
RESPECTO
OPORTUNIDADES
VIDAS PLENAS

"Comprender la personalidad es comprender la diversidad humana." ♥

Referencias bibliográficas:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.
- Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Terapia de esquemas: Guía práctica*. Editorial Desclee de Brouwer.
- Linehan, M. M. (2015). *DBT® Skills Training Manual (2.º ed.)*. Guilford Press.
- Millon, T., Grossman, S., & Meagher, S. (2015). *Trastornos de la personalidad en la vida moderna (2.º ed.)*. Elsevier.

Personas reales
Cambios posibles
Un futuro mejor ♥

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fuentes que sustentan el conocimiento, inspiran la práctica y guían el cambio.

INVESTIGACIÓN
PROFESIONALISMO
ACTUALIZACIÓN
COMPROMISO
BIENESTAR



EVIDENCIA
CIENTÍFICA



PRÁCTICA
CLÍNICA



CONOCIMIENTO
ACTUALIZADO



BASE PARA
EL CAMBIO

*Citar
también
es reconocer
el trabajo
de otros."*

- 1 American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5.ª ed., texto revisado; DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing.
- 2 Beck, J. S. (2011). *Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización*. Editorial Desclee de Brouwer.
- 3 Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Terapia de esquemas: Guía práctica*. Editorial Desclee de Brouwer.
- 4 Linehan, M. M. (2015). *DBT® Skills Training Manual* (2.ª ed.). Guilford Press.
- 5 Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). *Terapia de aceptación y compromiso (ACT)*. Editorial Desclee de Brouwer.
- 6 Caballo, V. E. (2019). *Manual de trastornos de la personalidad*. Pirámide.
- 7 Millon, T., Grossman, S., & Meagher, S. (2015). *Trastornos de la personalidad en la vida moderna* (2.ª ed.). Elsevier.
- 8 Corey, G. (2017). *Teoría y práctica de la psicoterapia*. Cengage Learning.
- 9 Norcross, J. C., & Wampold, B. E. (2018). *Psicoterapia: Teorías y métodos*. Manual moderno.
- 10 Organización Mundial de la Salud. (2019). *Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11)*. <https://www.who.int/es>
- 11 American Psychological Association. (2020). *Clinical Practice Guideline for the Treatment of Personality Disorders*. <https://www.apa.org>
- 12 Stahl, S. M. (2013). *Psicofarmacología esencial: Bases neurocientíficas y aplicaciones prácticas*. Editorial Médica Panamericana.

"Detrás de cada idea, hay muchas mentes que la hicieron posible."



CONOCER
MÁS



APRENDER
JUNTOS



APLICAR
MEJOR



GENERAR
CAMBIO

*El conocimiento
también es una forma
de cuidar."*



*La ciencia
también
transforma
vidas*



INVESTIGAR

APRENDER

COMPRENDER

APLICAR

TRANSFORMAR

*Buenas
referencias,
mejores
profesionales*



*La información
confiable construye
un futuro profesional
más humano."*



ÉTICA
RIGOR
CIENCIA
IMPACTO

CIENCIA

SALUD MENTAL

SOCIEDAD